EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93155
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-21 09:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN PASCUAL RIQUELME FUENTES			RUN	: 4.829.567-3
F.Nac	: 08-01-1943	Edad	: 81 AÑOS, 8 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BALMACEDA 01			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 82791131		
Fecha Ingreso	: 2024-09-18	Fecha Egreso	: 2024-09-21 09:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J98.2-ENFISEMA INTERSTICIAL.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

SDRA RESUELTA
EPID
HTA
DM2- IR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J98.2-ENFISEMA INTERSTICIAL. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes mórbidos de HTA; EPID, DM2 IR, en controles regulares por broncopulmonar, por neumonía por hipersenbilidad en fase crónica, donde se descarta UIP y Tr reumatológico, acude a SU HSC el 17/09 por cuadro de exacerbación de disnea de 6 hrs de evolución, ortopnea. A su ingreso se describe hiposaturando hasta 78% ambiental, con uso de musculatura accesoria, se inicia MAF a 15lts/min en primera instancia. Sin angina ni compromiso del sensorio al interrogatorio dirigido.
A su evaluación se describe P/A limite bajo, afebril, normocardico, bien perfundido, sin compromiso del sensorio.
Examenes de lab al ingreso -> glicemia 105; crea 1, lactato 3,9; PCR 38,4; uremia 35; Hb/Hcto 13.9/1.5; Gb 9,7; plaq 233000; segment 56%, INR 1,12, dimero D 1220,2; tropo 14,9; orina normal, GSA pH 7,46; pCO2 24, pO2 69,2, HCO3 17,3; PAFI 192
AngioTAC de torax se descarta TEP; ECG al ingreso sinusal.
Se procede a administración de terapia cortico esteroidal, sumado a NBZ con berodual.
Con mejoría progresiva posterior y destete de O2 suplementario, últimos GSA control con PAFI 233, FiO2 32%.
Con buena evolución, sin requerimiento to de oxigeno por mas de 24 horas, para metros inflamatorios bajos, sin quiebre clínico, en condiciones de HODOM.

PLAN DE MANEJO:

HODOM
Completar tto atb
continuar con tto crónico
control sos Urgencia según signos de alarma

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo
2. Régimen: Diabético Hiposodico A Tolerancia
3. Ceftriaxona 2 Gr Al Dia Ev Por 3 Dias
4. Azitromicina 500 Mg Al Dia Vo 1 Dia
5. Prednisona 20 Mg Dia Vo Por 5 Dias
6. Atorvastatina 20 Mg Al Dia Vo
7. Aspirina 100 Mg Al Dia Vo
8. Amlodipino 10 Mg Al Dia Pm Vo
9. Losartan 50 Mg C/12 Hrs Vo
10. Bromuro De Ipratropio 4 Puff C/4 Hrs Por Ac Por 5 Dias
11. Insulina Nph 8 Ui C/12 Hrs Sc
12. Quetiapina 25 Mg , Medio Comp Pm Vo
13. Knt Respiratoria

EXÁMENES Y RESULTADOS

-> crea 0,8; lactato 1,7; PCR 14; uremia 40; Na/K/Cl 134/4.1/106; Gb 5,8; Hb/Hcto 11.7/34.9; plaq 177000; segment 76%; proca 0,05

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO